

A Rural Mobility Platform for Elderly Care

병원 가는 길, 끝까지 책임집니다.

충주 읍·면 어르신들을 위한 AI 합승 통원 배차 플랫폼

— 진료 시간에 맞춘 왕복 배차와 자녀 실시간 보고

MEET THE FOUNDER

모빌리티 실전 경험 × **충주 로컬 감각**을 동시에 가진 창업가.

모시GO의 기획, 배차 시스템·앱·대시보드는 전부 대표가 직접 설계·개발한 결과물입니다.

CEO · FOUNDER

조영찬

Jo Yeong-chan · Developer

"충주는 저의 창업 지역이자, **어르신들의 통원 문제가 매일 눈에 보이는 곳**입니다. 배차 로직도, 자녀 앱도 제가 직접 만듭니다 — 문제를 이해하는 사람이 만들어야 진짜가 나옵니다."

Full-Stack모빌리티앱 · 웹 실전 배포충주 로컬

01 학력EDUCATION

건국대학교 서울캠퍼스

스마트ICT융합공학과 · 부전공 문화콘텐츠학과

재학

02 주요 수상AWARDS · RECOGNITION

2025. 12

코레일 내일로 해커톤

장려상

2026. 01

충주 청년 창업 아이디어 캠프

최우수상

2026. 06

디프만 (DEPROMEET) 18기

대상

03 경력EXPERIENCE

2025. 02 — 2026. 07

1년 5개월

서울소프트

모빌리티 개발팀 · Full-Stack Developer

운수사(버스·택시) 대상 ERP 서비스를 개발·제공하는 IT 기업에서 Full-Stack 개발자로 근무

OPENING SCENE

— 발표를 시작하기 전에

충주 산척면에 사는 박순덕 어르신(78세)은
주 3회 투석을 받습니다.

버스로 병원까지 환승 포함 1시간 20분,
배차 간격은 1~2시간.

지난달, 어르신은 투석을 두 번 걸렀습니다.

서울에 있는 아들은, 그 사실을 지금도 모릅니다.



이동이 이미 무료인 도시에서, 왜 어르신은 치료를 포기할까요?

충주는 2026년 5월부터 65세 이상에게 시내버스·콜버스가 월 15회 무료입니다. 그럼에도 읍·면 어르신은 투석을 포기합니다.

이 발표는, 그 이유를 밝히고
그것을 사업으로 푸는 방식에 대한 이야기입니다.

THE PROBLEM

이동이 무료인 도시에서, 어르신은 치료를 포기합니다.

가격이 아니라 구조가 문제입니다. 총주 읍·면에서는 교통·의료·돌봄이라는 세 개의 공백이 동시에 겹쳐, "병원에 갈 수는 있지만 제때 갈 수는 없는" 상태가 만들어집니다.

GAP 01 · 교통 버스로는 진료 시간을 맞출 수 없습니다. 호출형 콜버스는 진료 시간을 보장하지 않고, 귀가 편은 병원 앞에서 다시 호출해야 합니다. 읍·면 → 거점병원 소요 1시간+ 버스 배차 간격 1~2시간 저상버스 비율 (82대 중) 3.7% 출처 · 비마이너 (2020) · 충주시 교통 현황	GAP 02 · 의료 이동이 안 되면, 치료를 포기합니다. 투석 주 3회 · 연 150회. 재할 주 2~3회. 정기 통원은 곧 생존과 직결됩니다. 전국 투석 환자 81,306명 인구 10만 명당 157명 만성콩팥병 유병률 (19세+) 6.3% 출처 · 대한신장학회 등록사업 (2024) · 질병관리청 (2024)	GAP 03 · 돌봄 가족은 아무것도 모릅니다. 통원일마다 연차를 내거나, 어르신이 혼자 갑니다. 진료 내용·처방 변경을 가족 누구도 모릅니다. 보호자에게 보고하는 기존 수단 0건 자녀 수도권 거주 비중 과반 단발 매칭 앱의 지방 공급자 부재 기존 이동·동행 수단 6종 분석 결과
--	---	---

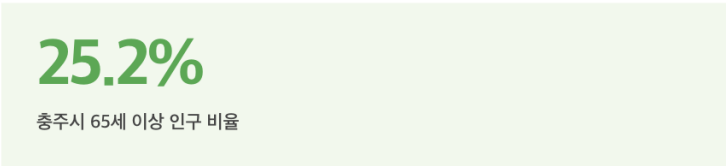
WHY NOW

수요·정책·공백이 지금 동시에 열렸습니다.

시장을 만들 필요가 없습니다. 수요는 이미 초고령사회에 진입해 있고, 예산은 열려 있으며, 지방에는 아무도 없습니다.
세 개의 곡선이 이 시점에 정확히 교차합니다.

01 · 수요 DEMAND

이미 초고령사회에 진입했습니다.

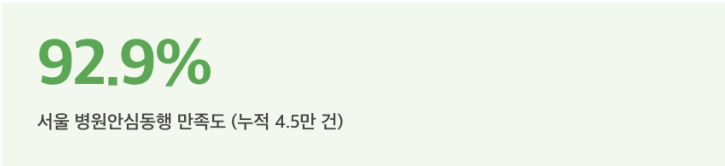


충청북도 평균	22.7%
전국 평균	20.8%
인접 괴산군	43.0%

출처 · 행정안전부 주민등록 인구통계 (2025.8)

02 · 정책 POLICY

지자체 예산이 이미 열려 있습니다.

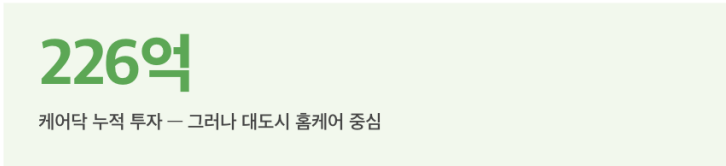


춘천시 병원동행	시간당 5,000원
DRT 가이드라인	2025.12
운수사 상생모델	명시 권장

출처 · 서울시 1인가구포털 · 춘천시 복지포털 · 국토교통부

03 · 공백 WHITE SPACE

지방에는 아무도 없습니다.



케어네이션 다운로드	32.5만 건
위드메이트	차량 미제공
지방 공급자 밀도	부재

출처 · THE VC · 시선뉴스 · 각 사 공식 자료

MARKET SIZE

충주에서 검증하고, 전국 시·군으로 복제합니다.

MARKET STRUCTURE · TAM / SAM / SOM

보수적으로 잡습니다. 성장 논리는 "복제"입니다.

TAM 전국 비수도권 시·군 통원 이동지원 시장

3,000억 원 +

100%

전국 군 단위 82개 + 도농복합시. 대부분 충주와 동일한 의료·교통 공백 보유 — Top-down 추정

SAM 충북 북부권 (충주·제천·음성·괴산·단양)

301억 원 / 연

10.0%

5개 시·군 65세 이상 약 12만 명 × 통원 수요 30% × 연 24회 × 3.5만 원

SOM 충주시 1읍 12면

46억 원 / 연

1.5%

읍·면 65세 이상 1.8만 × 침투율 30% ≈ 5,400명 × 연 24회 × 3.5만 원 — 파일럿(북부 3면 25%) 검증 후 전 읍·면 평균 15%로 보수적 조정

BOTTOM-UP · 파일럿 권역 (북부 3면)

인구 6,900명 → 월 잠재 수요 673건

1

산척·엄정·소태면 총 인구

6,900명

2

65세 이상 ×30% (읍·면 고령화율)

2,090명

3

투석 11 · 재활 31 · 외래 188
+ 질환별 통원 빈도 적용

월 673건

1YR PILOT TARGET · 침투율 20~30%

월 130~200건 · 이용자 50~60명

투석 유병률 인구 10만당 157명 · 대한신장학회 등록사립 (2024)

THE SOLUTION

진료 시간·왕복·보고를 하나의 흐름으로 묶습니다.

진료 예약을 기준으로 배차하고, 왕복을 페루프로 닫고, 자녀를 서비스의 수신자로 설계합니다. **어르신은 부르지 않고, 자녀는 연차를 내지 않습니다.**

#	공백	원인	모시GO의 해결
01	교통 공백 버스로는 진료 시간을 못 맞춘다	호출형 교통은 이용자가 부른 시각 이 기준 — 진료 시간을 계약하지 않는다	진료 예약에서 역산 배차 10시 진료 → 접수·대기 감안 09:20 픽업 . 부르지 않고, 일정만 등록
02	의료 공백 이동이 안 되면 치료를 포기한다	편도 단위라 귀가가 보장되지 않는다. 진료 종료 시각이 유동적이라 재호출 필요	왕복 페루프 거점병원이 2곳뿐 → 차량이 병원에 상주 . 진료 종료 후 5분 내 탑승
03	돌봄 공백 가족이 아무것도 모른다	이용자 = 지불자 구조라 보호자가 서비스의 수신자가 아니다	자녀를 수신자로 설계 탑승·도착·지연·귀가마다 푸시 알림 . 귀가 후 AI 통원 리포트 발송

A DAY · 한 번의 통원

어르신이 하는 일은 없습니다.

전날	배차 확정 자녀 알림
09:20	문 앞 픽업 자녀 알림
09:43	병원 정문 하차 자녀 알림
진료 중	차량 병원 상주 · 지연 시 자녀에게 알림 변수가 서비스로
12:40	자택 도착 → AI 리포트 발송

전화도, 앱도, 재호출도 하지 않습니다. — **어르신이 없어도 서비스가 돌아갑니다.**

예약 8건이, 3개 노선으로 묶입니다.



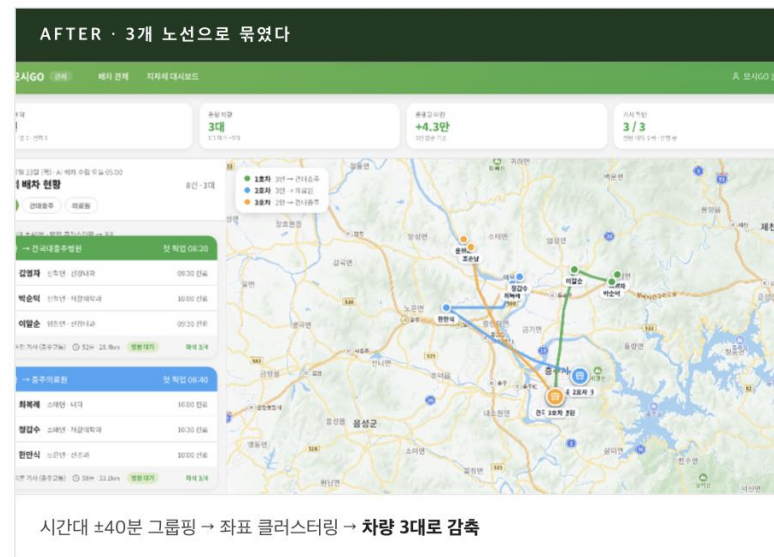
AI가 새벽 5시에 자동 수립한 오늘의 배차 — 사람이 누른 버튼은 없습니다. 예약 8건이 흩어져 있던 지도가, 3개 노선으로 묶입니다.

BEFORE / AFTER · AI 합승 배차 시뮬레이션

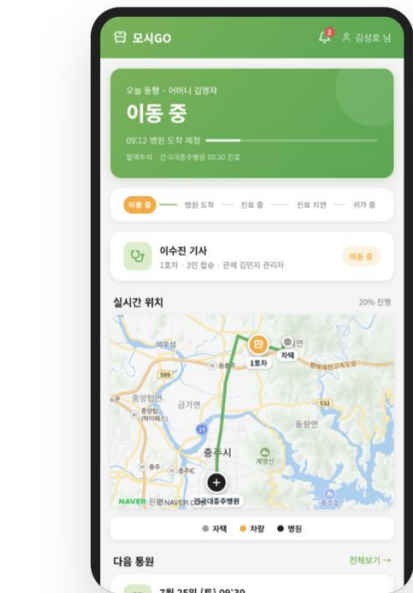
예약 8건 · 차량 8대 → 3개 노선 · 차량 3대

GUARDIAN APP · 자녀 앱

보호자는 수신자입니다.



차량 감축 -62.5% 8대 → 3대	운행당 마진 +4.3만 1:1 배차는 -13.6만	사람 개입 0회 지자체 행정 부담 제로	기사 확인 3 / 3 오늘의 배차 완료
--	---	---	---



실시간 위치 · 진행 단계 배차 · 다음 통원 예약이 하나의 화면에.
이용자 · 지불자를 분리한 유일한 대안입니다.

HOW IT WORKS

한 번의 통원이 세 개의 화면으로 이어집니다.



같은 통원 한 건이 어르신에게는 부르지 않아도 되는 이동, 자녀에게는 연차 없이 확인하는 안심, 관리자에게는 동행 없이 관제하는 운영으로 각각 다르게 도달합니다.

PERSONA 01 · 어르신

부르지 않아도 되는 이동

기준: 매 회차 콜버스·택시를 부르고, 귀가 편은 다시 호출.
→ 진료 일정만 등록하면 매 회차 자동 배차.

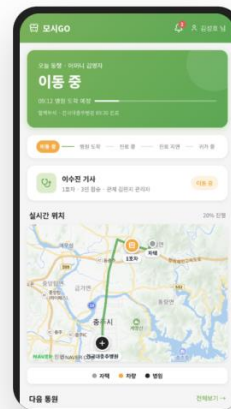


- ✓ 정기 통원 주 3회 (월·수·금) 자동 등록
- ✓ 진료 시간에서 역산해 픽업 시각 결정
- ✓ 휴진·변경은 관리자에게 전화 한 통

PERSONA 02 · 자녀 (보호자)

연차 없이 확인하는 안심

기준: 통원일마다 연차, 진료 결과는 어르신 기억에만 의존.
→ 실시간 위치 + 귀가 후 SI 통원 리포트.

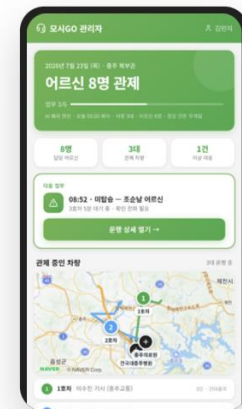


- ✓ 탑승·도착·지연·귀가 4단계 푸시
- ✓ 진료 종료 후 SI 통원 리포트 자동 발송
- ✓ 다음 예약·처방 변경까지 한 화면에

PERSONA 03 · 관리자

동행 없이 관제하는 운영

기준: 동행 인력이 1:1로 붙어야 → 지방에서 원가 붕괴.
→ 관리자 1명이 하루 수십 건 관제-이상 대응.



- ✓ 미탑승·지연 이상 신호 자동 알림
- ✓ 사무실에서 여러 차량 동시 관제

COMPETITIVE MOAT

"총주에 이미 수단이 있는데?" — 전 열을 채우는 것은 하나뿐입니다.

콜버스는 있습니다. 무임교통도 있습니다. 그런데도 어르신은 투석을 포기합니다. 문제는 이동이 아니라 진료 시간·왕복·보호자 보고의 결합입니다.

경쟁 구도 · 총주 현장 기준

비교 항목	모시GO	총주콜버스	장애인콜택시	민간 동행	무임교통
이동 제공	O	O	△ 자격	X 교통비 별도	O
진료 시간 보장	O	X	△ 예약제	—	X
왕복 페루프	O	X 편도	△	—	X
보호자 보고 (푸시)	O	X	X	△ 대행	X
정기 통원 설계	O	X	X	X 단발	X
지방 성립	O	O	△ 공급	X 공급·가격	O

O 제공 △ 제한적 X 제공 안 함 — 해당 없음

WHY OTHERS CAN'T

세 개의 구조적 장벽이 있습니다.

BARRIER 01 · 데이터

교통 사업자는 '의료 일정'을 모른다

콜버스·택시는 이용자가 부른 시각이 기준. 진료 예약 데이터를 다루지 않으므로 시간 역산이 불가능합니다.

BARRIER 02 · 원가

동행 서비스는 지방에서 원가가 붕괴한다

1:1 동행은 건당 인건비 4만 원대가 고정. 경기도가 31개 시군 중 11곳만 운영하고 확대가 멈춘 이유입니다.

BARRIER 03 · 밀도

매칭 플랫폼은 공급자 밀도 없이 안 된다

위드메이트·케어네이션은 프리랜서 매칭. 총주 읍·면에는 매칭할 동행인 풀 자체가 없습니다.

HOW WE MAKE MONEY

먼저 증명하고, 그 데이터로 예산을 가져옵니다.

1년차는 자녀 결제(B2C)로 먼저 운영하며 성과 데이터를 만들고, 2년차에 그 데이터를 근거로 지자체 계약(B2G)을 가져옵니다. 2~3년차에는 검증된 운영 체계를 타 지자체에 라이선스로 판매합니다.

STAGE 01 · B2C 1Y 단가 회차 단위	고객 자녀 (보호자) 수도권 거주 보호자	자녀 결제로 먼저 운영을 시작합니다 지자체 예산을 기다리지 않고, 이용자·지불자가 분리된 구조를 활용해 자녀(보호자)에게 직접 판매합니다. 통원권(구 독·회수권)으로 스스로 매출을 만듭니다. + 여기서 성과 데이터를 만듭니다 — 정시 도착률·치료 중단율·재이용률·읍면별 수요·질환별 이용 추이. 2단계 지자체 계약의 근거 자료가 됩니다.	원가를 62% STRUCTURE 차량 + 관리자 필요
STAGE 02 · B2G 2Y 단가 건당 3.5만 원	고객 충주시 지자체 이동지원 예산 · 바우처	데이터를 근거로 바우처·예산 계약을 가져옵니다 1단계에서 검증한 KPI(정시율·치료중단율·비용효율)를 근거로 충주시 이동지원 바우처에 편입. 기존 예산의 운영 효율 을 우리가 증명하고 위탁받습니다. 자녀 결제와 병행됩니다 — 바우처 우선 차감 → 초과분·비대상자만 자녀 결제. 매출은 이중화, 원가는 그대로.	원가를 62% STRUCTURE 1단계와 동일
STAGE 03 · LICENSE 2~3Y 단가 도입비 + 연 라이선스	고객 타 지자체 전국 사·군 (비수도권 우선)	운영 체계 패키지 — 우리는 운영하지 않습니다 충주에서 검증된 운영 체계 자체를 판매. 각 지자체가 지역 운수사와 직접 운영하고, 우리는 시스템·매뉴얼·컨설팅만 공급합니다. 도입비(초기 셋업) + 연 라이선스(시스템 유지·업데이트). 차량·인력 없이 확장됩니다.	STRUCTURE 한계비용 거의 0

STAGE 03 · LICENSING

패키지 5종 구성으로
운영 체계를 팝니다.

WHAT WE SELL

01 AI 배차 시스템 — 지역 브랜딩 지원

02 운영 매뉴얼 — 배차·CS·이상 대응 SOP

03 지자체 제안 키트 — 조례 템플릿 · 예산 근거 · 충주 실증 데이터

04 접근성 대시보드 — 읍·면별 수요 지표

05 초기 셋업 지원 — 3개월 온보딩 컨설팅

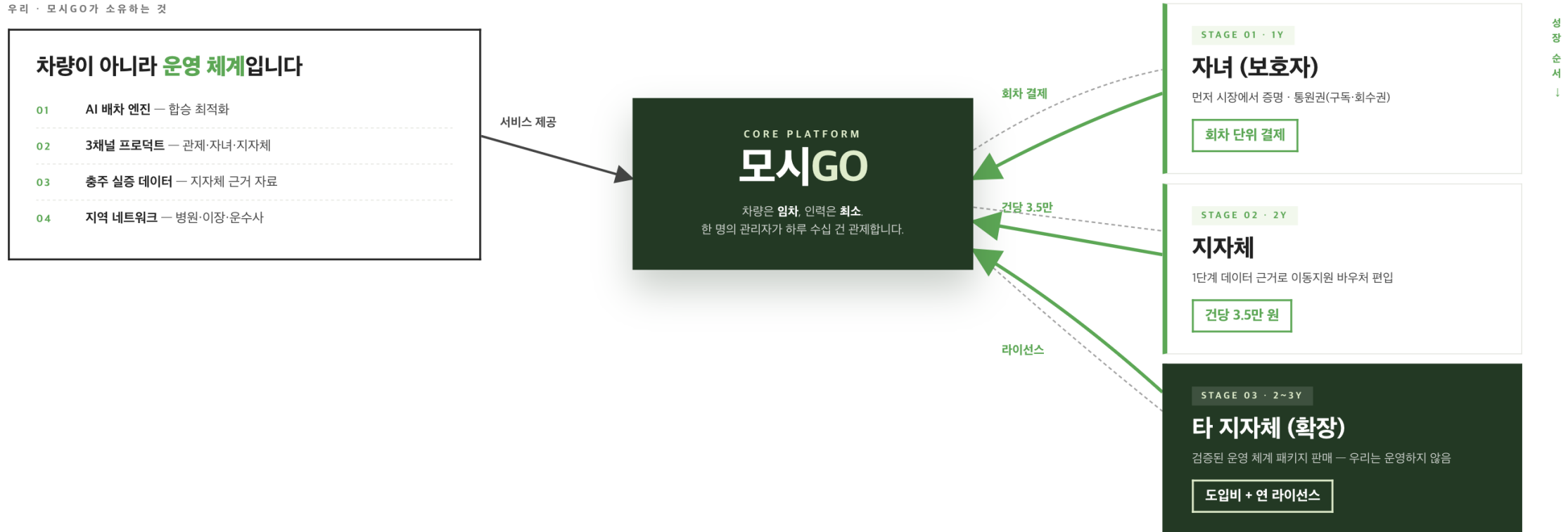
WHY IT SELLS · 2026.03.27

돌봄통합지원법 시행으로 이동지원이 지자체 의무가 되지만 검증된 운영 모델이 없습
니다. 처음부터 설계하느니 검증된 패키지를 사는 게 빠르고 안전합니다.

돈은 세 곳에서 들어옵니다.

자녀(보호자)에게서 시작해, 지자체 계약으로 확대되고, 검증된 운영 체계는 다시 다른 지자체로 팔립니다.

우리 · 모시GO가 소유하는 것



UNIT ECONOMICS

1:1이면 **-13.6만**, 합승이면 **+9.4만**.

앞의 모든 논리가 이 한 줄로 수렴합니다 — AI 배차는 기술 과시가 아니라 수익모델 그 자체입니다.

1회 운행 · 어르신 3인 합승 기준		
운행 하나가 만들어내는 마진		
수입	바우처 3.5만 × 3인	+105,000
비용	차량 왕복 임차 → 운수사 지급	-52,000
비용	운영비 (관리자 인건비 분산)	-10,000
MARGIN	운행당 기여 마진	+43,000
1인당 +14,300원 · 파일럿에서 계약으로 확장할 설계 가정		

CARRIER PERSPECTIVE · 운수사 관점 (대일운수 · 앤씨비)		
우리가 운수사에 지급하는 금액과, 왜 그들에게 매력적인가		
왕복당 지급 52,000원 기사 인건비 · 유류비 · 감가상각 포함	1대 · 오전 2회전 · 월 22일 월 229만원 차량 1대당 안정적 오전 수요 확보	파일럿 3대 기준 월 687만원 고정 정기 수요 · 오전 유휴 차량 활용

SAME DEMAND · 같은 8명을 태울 때

필요 차량이 **8대에서 3대로 줄어듭니다**.

	1:1 배차	AI 합승 배차
필요 차량	8대	3대 (-62.5%)
차량 비용	41.6만	15.6만
수입 (바우처 3.5만 × 8인)	28.0만	28.0만
손익	-13.6만 적자	+9.4만 흑자

LTV / CAC · 정기 통원 환자 (투석 기준)			
투석 환자는 치료가 지속되는 한 이탈하지 않습니다.			
연간 이용 150회	1인당 회당 마진 14,300원	연간 기여마진 215만	3년 LTV 645만

PROOF PLAN

충주 북부 3면에서, 6개월 안에 6개 지표로 증명합니다.

"기술보다 수요 검증 먼저" — 초기에는 앱 없이 전화·스프레드시트로 시작해 실제 수요를 확인한 뒤 제품화합니다.

PILOT SPEC · 충주시 북부 3면 (산척·엄정·소태)

인구 6,900명 · 고령 2,090명 · 잠재 월 673건

참여자
20 → 58명
1단계 → 6개월 후

차량
2 ~ 3대
휠체어 대응 1대 포함

월 운행
60 → 200건
점증 · 침투율 25%

운영 인력
관리자 1명
동행 인력 없음

질환 · 참여자 구성 (침투율 25%)	잠재	목표	월 이용	월 건수
혈액투석	11명	3명	주 3회 (월 13회)	36건
재활치료	31명	8명	주 2회 (월 8회)	62건
만성 외래	188명	47명	월 1.5회	70건
합계	230명	58명	평균 월 2.9회	약 170건

6 KPIs · 무엇을 증명할 것인가

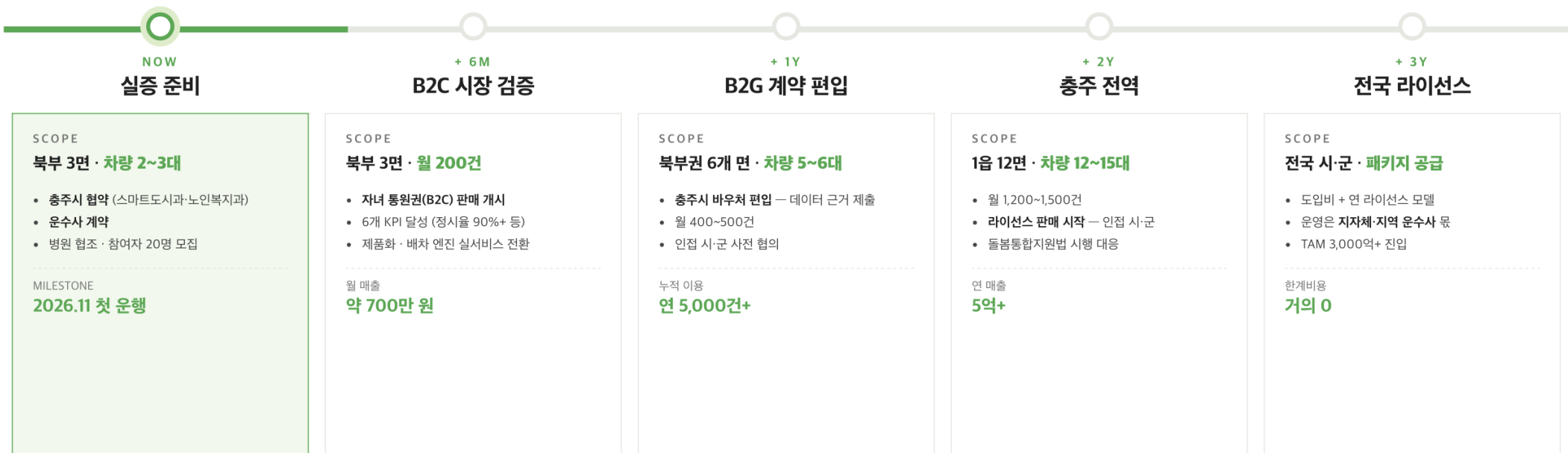
6개월 후 이 여섯 개의 숫자가 확대 계약의 근거가 됩니다.

1	정시 도착률 콜버스가 못 하는 것이 시간 보장 — 우리 존재 이유	90%+
2	귀가 대기 시간 병원 상주 배차의 실현 증거	≤ 15분
3	치료 중단율 의료 공백 해소의 최종 지표 · 병원 B2B 근거	0%
4	재이용률 정기 통원이므로 이탈이 곧 서비스 실패	90%+
5	자녀 리포트 만족도 B2C 전환의 선행 지표	85%+
6	운행당 마진 시뮬레이션이 현실에서 성립하는지	+4.3만

EXPANSION ROADMAP

확장 논리는 매우 단순합니다.

신규 지역 진입에 필요한 것은 **운수사 계약 + 관리자 1명 + 지자체 협약** 세 가지뿐입니다. 자본 투입 없이 시·군 단위로 복제됩니다.



Q&A

ONE-LINE ANSWER

저희가 파는 것은 이동이 아니라,
약속을 지키는 운영 체계입니다.